

Tue, Jun 30 at 10:08 PM

피지오가 체크한 ankle dorsiflexion 은 0/5 이고 뉴로로지스트가 체크한거는 3/5야

NDIS High Cost AT Report나 Bioness L300 Go 보고서에서 이런 경우는 두 수치가 다르다는 사실을 숨기지 말고 그대로 설명하는 것이 가장 좋습니다.

MMT(Manual Muscle Testing)는 검사자, 검사 자세, 보상 움직임 허용 여부, 피로도, 검사 시점에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 특히 MS 환자의 경우 변동성이 흔합니다.

보고서에는 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

Muscle Strength Assessment

There is variability in the documented right ankle dorsiflexion strength across assessments.

Neurologist assessment: Right ankle dorsiflexion 3/5.

Physiotherapy assessment: Right ankle dorsiflexion 0/5.

The difference between assessments is likely related to variations in testing conditions, fatigue levels, examiner technique, and the fluctuating nature of Multiple Sclerosis. During orthotic assessment and gait observation, the participant demonstrated significant functional foot drop with inadequate active dorsiflexion during swing phase, resulting in reduced toe clearance and increased risk of tripping.

Regardless of the numerical MMT grading recorded by different clinicians, all assessments consistently identified clinically significant dorsiflexion weakness that adversely affects gait safety, efficiency, and community mobility.

추가로 Bioness 보고서에서는 실제로 MMT 수치보다 기능적 증거(functional evidence) 가 더 중요합니다.

예를 들어 다음과 같은 내용이 함께 있으면 설득력이 훨씬 강해집니다.

Foot drop observed during gait

Reduced toe clearance

Frequent tripping episodes

Compensatory hip hiking/circumduction

Increased falls risk

Improvement during Bioness trial

Decline during washout period

만약 최종 제출본이라면, 저는 Baseline Strength를 0/5로 단정하지 말고 "0-3/5 documented across clinical assessments" 로 정리한 후, 핵심은 "functional foot drop was consistently present"로 연결하는 방식을 권장합니다. NDIS 심사관은 근력 숫자 자체보다 실제 보행 기능 저하와 AT 사용 효과를 더 중요하게 봅니다.